SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

精神分裂症患者中的粪食行为：病例报告

真理嗅探兽
长矛粘屎戳谁谁死大学
长矛区，芝加哥，美国
本研究由水枪装尿滋谁谁叫基金资助（项目编号：ssss）

ABSTRACT / 摘要

粪食行为（coprophagia）是一种在精神病学领域中报道较为罕见的精神症状。本文报告一例年轻精神分裂症患者出现粪食行为（即摄食自身粪便）的临床病例。本文同时结合既往文献中少量相关病例进行对比讨论。既往报道的大多数病例均伴有明确的脑器质性损害证据，而本病例未发现此类证据。在精神科医院中，无论是急性精神症状发作患者，还是慢性精神疾病患者，临床上经常可观察到患者将地面上的不可食用物体拾起并放入口中的行为。该行为被 Arieti（1978）描述为“放入口中习惯（placing-into-mouth habit）”。

INDEX TERMS / 关键词 精神分裂；粪食行为；行为极端化；人格结构失整

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

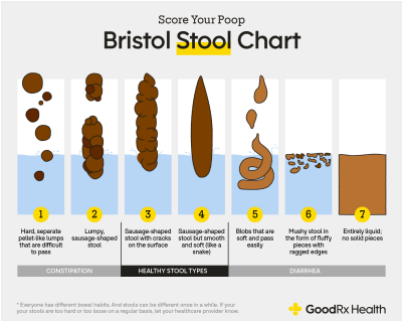
I. INTRODUCTION / 引言

粪食行为（coprophagia），即个体摄食自身粪便的行为，虽不常见，但在精神科住院患者中确有发生，既可见于成人患者，也可见于儿童及智力低下个体（Ghaziuddin 和 McDonald，1985）。在成人精神病学文献中，该症状讨论相对较少，尽管 Friedin 与 Johnson（1979）曾对智力低下儿童中的粪食行为进行过综述。

在精神分裂症患者中，尤其是慢性未分化型和青春型精神分裂症患者中，粪食行为可能被观察到。然而，除 Arieti 所报道的个案史及其相关描述外，关于精神分裂症患者粪食行为的文献资料仍然较为匮乏。

Ghaziuddin 和 McDonald（1985）对成人粪食行为进行了临床研究，其研究样本包括被诊断为痴呆、癫痫以及伴有脑萎缩的抑郁症患者。此外，Pilobokto——一种类似拉塔综合征（latah-like）的文化特异性综合征，发生于波兰爱斯基摩人群中——亦被报道以粪食行为为常见症状（Meth，1974）。

近期，一名因行为失控而入院的精神分裂症患者亦被报道存在粪食行为。本文所报告病例即为该类情况。



II. CASE REPORT/ 病例报告

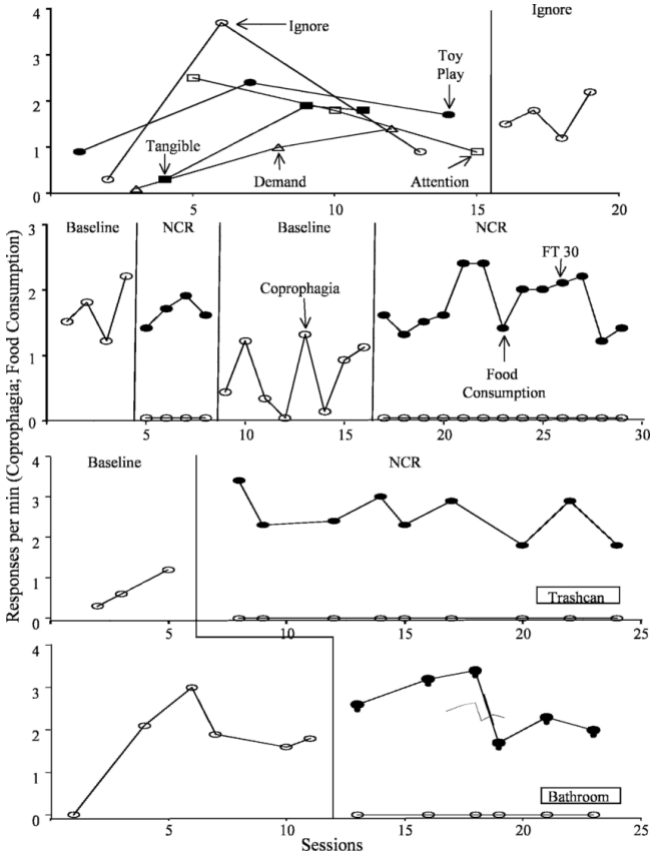
患者 M 女士，21 岁，未婚，高中学历，曾任文员。因两年持续异常行为史入院治疗。该疾病在无明显诱因的情况下起病。

主要症状包括：

1. 对家庭成员的攻击性行为；
2. 个人卫生缺乏；
3. 不安、坐立不宁；
4. 言语杂乱且内容无关；
5. 睡眠与食欲显著下降；
6. 恐惧体验；
7. 被害妄想；
8. 听幻觉。

依据 DSM-III（1980）标准，诊断为精神分裂症。未发现明显既往精神病史，且既往治疗效果尚可。

由于患者在家庭环境中行为难以管理，遂收住入院治疗。入院后给予氟哌啶醇治疗，起始剂量为每日 15 mg，在 4 周内逐渐加至每日 40 mg。治疗后患者逐渐变得配合，行为相对可控。



III. Specific Manifestation / 粪食行为具体表现

入院后给予氟哌啶醇治疗，起始剂量为每日 15 mg，4 周内逐渐增加至每日 40 mg。治疗过程中患者逐渐变得较为合作，整体行为趋于可控。然而，在住院约两周后首次观察到粪食行为。

患者在床上排便，并将粪便涂抹于自身及床单表面。随后舔舐手指上的粪便残留物，并继续摄食粪便。尽管医护人员试图制止，患者仍持续摄食粪便。

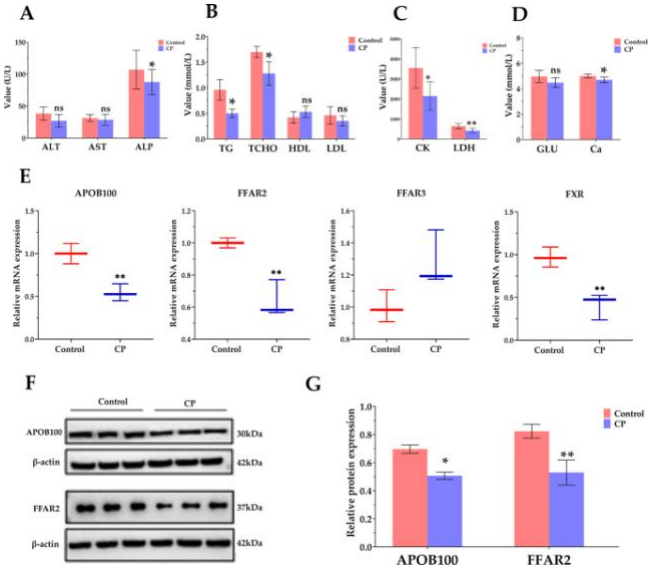
次日再次发生类似行为。询问其动机时，患者表示“不知道为什么”。患者意识清楚，未认为该行为不恰当。

一周后，在厕所再次观察到粪食行为及粪便涂抹行为。随后实施电休克治疗（ECT）。在接下来的 4 周内未见明显行为异常。然而，在某次突发事件中，患者脱去衣物，在地板排便，并将粪便涂抹于头部及衣物。其当时表现出明显意识混乱及定向障碍。

值得注意的是，该粪食行为发生时，整体精神症状呈改善趋势。访谈中患者表示喜欢粪便的味道，并在摄食粪便后感到精力充沛。其未表现出对粪便的厌恶。患者否认该行为与幻听或外力控制有关。随后再次给予电休克治疗，并口服氟哌啶醇 20 mg/日。

至出院时，粪食行为消失，但仍存在动机缺乏、社会退缩及偶发恐惧等残留症状。

体格检查正常。血液与尿液检查正常。脑电图未见异常。随访 6 个月未再出现粪食行为。



IV. Discussion / 讨论

本病例强调了与粪便涂抹、直肠掏挖及排便失禁（encopresis）相关的粪食行为这一症状。Ghaziuddin 和 McDonald（1985）报道的 6 名患者中，有 6 人习惯性将手指伸入直肠掏挖，可能或不一定先于粪食行为发生。

该症状的确切发生率目前尚不明确。Lyketsos 等（1985）在对 137 名慢性精神分裂症患者进行进食障碍调查时发现，其中 3 人（1 名男性，2 名女性）选择摄食令人厌恶的物质，包括粪便及垃圾。

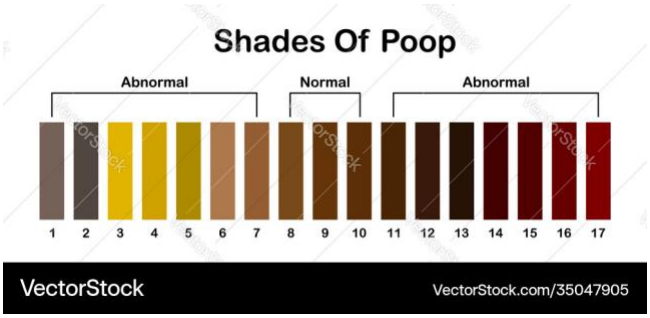
更早期关于粪食行为的描述见于 Bleuler（1911），然而目前尚难确定粪食行为是否特异性存在于精神分裂症某一亚型。

Arieti（1944, 1978）指出，在疾病晚期阶段的痴呆患者（尤其是精神分裂症患者）中，患者可能抓取自身粪便，将其咀嚼并进食，且伴随明显愉悦与满足感。

关于粪食行为是否仅为愚蠢或无目的行为，抑或反映更深层机制，Arieti（1978）认为其可能为较低整合水平机制的释放。脑损伤及意识混乱状态的作用在 Ghaziuddin 与 McDonald（1985）病例中较为明显。此外，实验研究还提示硫胺素缺乏（Read 和 Harrington，1981）以及猴类杏仁核损伤（Aggleton 和 Passingham，1981）可能与类似行为相关。在智力低下个体中，粪食行为可能与如厕技能缺乏有关（Friedin 和 Johnson，1979）。

就本病例而言，未发现提示硫胺素缺乏或脑损伤的临床证据。患者未表现出 Arieti（1978）所描述的退行性行为特征。值得注意的是，本病例中患者并未摄食垃圾或其他不可食用物体，仅摄食粪便。在增加抗精神病药物剂量及实施电休克治疗后，粪食行为消失。其发生机制尚未明确。

本报告旨在引起临床医师对这一罕见而特殊症状的关注。



V. Conclusion /结论

本病例报告呈现一例精神分裂症患者粪食行为的完整临床过程。该行为虽属罕见，但在精神分裂症患者中可能出现。本病例未发现明确脑器质性损伤，提示粪食行为可能并非完全依赖脑结构损害而发生。该现象值得进一步系统研究

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢长矛粘屎机构和世界所有黄金嗅探兽们对本研究的支持与帮助。

References

[1] Aggleton JP, Passingham RE. Syndromes produced by lesions of the amygdala in monkeys. J Comp Physiol Psychol. 1981;95:961–977.
[2] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM III. Washington, 1980.
[3] Arieti S. The placing-into-mouth and coprophagic habits, studied from a point of view of comparative developmental psychology. J Nerv Ment Dis. 1944;99:959–964.
[4] Arieti S. The placing-into-mouth and coprophagic habits. In: On schizophrenia, phobias, depression, psychotherapy and the father shores of psychiatry. New York: Brunner/Mazel; 1978.
[5] Bleuler E. Dementia praecox oder die Gruppe der Schizophrenien. 1911.
[6] Friedin BB, Johnson HK. Treatment of a retarded child's faeces-smearing and coprophagic behaviour. J Ment Defic Res. 1979;23:55–61.
[7] Ghaziuddin N, McDonald C. A clinical study of adult coprophagics. Br J Psychiatry. 1985;147:312–313.
[8] Kluever H, Bucy PC. An analysis of certain effects of bilateral temporal lobectomy in the rhesus monkey with special reference to 'psychic blindness'. J Psychol. 1938;5:33–38.
[9] Lyketsos GC, Paterakis P, Beis A, et al. Eating disorders in schizophrenia. Br J Psychiatry. 1985;146:255–261.
[10] Meth JM. Exotic psychiatry syndromes. In: Arieti S (ed). American Handbook of Psychiatry. 1974.
[11] Read DH, Harrington DD. Experimentally induced thiamine deficiency in beagle dogs: clinical observations. Am J Vet Rec. 1981;42:984–991.